

KlinikIQ İç Hastalıkları Vakaları Ultra Refined Raporu

Bu rapor, Klinik Branş Seç / Klinik Vakalar / Olgular / Diğer Olgular içinde branchId=internal-medicine olan genel klinik vakalara uygulanan vaka vaka yeniden yazım ve kalite güçlendirme işlemini özetler. TUS Spot Olgulara, API endpointlerine, component mimarisine, glossary veya hap bilgi kartlarına müdahale edilmemiştir.

Özet Metrikler

Metrik	Değer
Taranan İç Hastalıkları vaka sayısı	26
Güncellenen İç Hastalıkları vaka sayısı	26
Sol kolon metni yeniden yazılan vaka sayısı	26
Objektif veri/tetkik alanı düzeltilen vaka sayısı	26
Olgu/tetkik katmanı kapsamı artırılan vaka sayısı	26
Lab/görüntüleme/mikrobiyoloji/patoloji ayrımı düzeltilen vaka sayısı	26
Fizik muayene/görsel açıklaması güçlendirilen vaka sayısı	26
Kolon/referans/birim/kısa yorum hatası düzeltilen satır/kayıt	31
Alakasız/generic kısa yorum temizlenen vaka sayısı	20
Kısa yorum sıfırdan yazılan kayıt sayısı	108
Gereksiz kısa yorum kaldırılan/gizlenen kayıt sayısı	38
Soru kökü güncellenen vaka sayısı	26
Seçenek seti güçlendirilen vaka sayısı	26
Seçenek metni değiştirilen seçenek sayısı	65
OptionFeedback sıfırdan yazılan seçenek sayısı	130
Klinik/Bilimsel gerekçe yeniden yazılan vaka sayısı	26
Kanıt zinciri yeniden yazılan vaka sayısı	26
Sınav notu/Core Knowledge/Exam Pearl güçlendirilen vaka sayısı	26
Scientific concern sayısı	0
ID değişikliği	Yok
TUS Spot Olgulara dokunuldu mu?	Hayır
JSON/import kontrolü	passed
Build durumu	failed: vite not found because node_modules/project dependencies are not installed in the sandbox

Vaka Bazlı Kapsam Özeti

Vaka ID	Başlık	Öğrenme hedefi	Yeni soru kökü	Doğru cevap
v163-new-002-acil-elektrolit-bozukluğu	Acil elektrolit bozukluğu	EKG değişikliği olan hiperkalemi ilk tedavinin intravenöz kalsiyum olduğunu açıklama.	Kronik böbrek hastalığı zemininde ağır hiperkalemi ve EKG değişikliği bulunan bu hastada ilk acil yaklaşım hangisidir?	İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi
v164-new-011-acilik-ve-kusma-sonrası-metabolik-k-bozulma	Açlık ve kusma sonrası metabolik bozulma	DKA olgusunda sıvı resüsitasyonu, potasyum güvenliği ve insülin zamanlaması arasındaki öncelik sırasını açıklama.	Hiperglisemi, ketonemi, anyon açıklıklı metabolik asidoz ve dehidratasyon bulguları olan bu hastada ilk tedavi basamağı hangisidir?	İzotonik salin ile intravenöz sıvı resüsitasyonu başlamak
v164-new-014-purpura-ve-nörolojik-bulgular	Purpura ve nörolojik bulgular	TTP ile ITP, DIC, HÜS ve sepsis ilişkili trombositopeniyi ayırarak tedaviyi geciktirmeme mantığını açıklama.	Peteşi-ekimoz, ağır trombositopeni, şistositli hemoliz ve nörolojik dalgalanma bulunan bu hastada acilen başlanması gereken tedavi hangisidir?	Acil terapötik plazma değişimi
v164-new-017-yeni-başlayan-temporal-baş-ağrısı	Yeni başlayan temporal baş ağrısı	Dev hücreli arteritte temporal arter biyopsisi beklenmeden kortikosteroid başlanması gerektiğini açıklama.	Yeni başlangıçlı temporal baş ağrısı, çene klodikasyonu ve geçici görme bulanıklığı bulunan bu hastada görme kaybını önlemek için ilk yaklaşım hangisidir?	Yüksek doz sistemik kortikosteroid başlamak

Vaka ID	Başlık	Öğrenme hedefi	Yeni soru kökü	Doğru cevap
v164-new-018-hemoptiz i-ve-hematuri-birlikteligi	Hemoptizi ve hematüri birlikteliği	Anti-GBM hastalığını ANCA vaskülit, IgA nefropatisi ve poststreptokokal GN'den ayırma.	Hemoptizi, hipoksemi, hızlı kreatinin artışı ve aktif idrar sedimenti bulunan bu hastada en olası tanı hangisidir?	Anti-GBM hastalığı
v164-new-020-antibiyoti k-sonrasi-ishal	Antibiyotik sonrası ishal	C. difficile kolitinde oral vankomisin tedavisini destekleyen klinik ve laboratuvar bulgularını açıklama.	Geniş spektrumlu antibiyotik sonrası sulu ishal, lökositöz ve dışkıda C. difficile toksin pozitifliği olan bu hastada en uygun tedavi hangisidir?	Oral vankomisin tedavisi başlanması
v165-new-021-acilik-ve-kusma-sonrasi-metaboli k-bozulma	Açlık ve kusma sonrası metabolik bozulma	DKA tedavisinde potasyum düzeyinin insülin kararını nasıl değiştirdiğini açıklama.	DKA ile uyumlu asidoz ve hiperglisemi saptanan bu hastada insülin tedavisine geçmeden önce en uygun yaklaşım hangisidir?	Potasyum replasmanı yapıp insülini potasyum güvenli aralığa çıkana kadar ertelemek
v165-new-024-ates-ve-y eni-ufurum	Ateş ve yeni üfürüm	Endokardit etkenlerini klinik bağlam ve kapak/risk faktörü ilişkisiyle ayırt etme.	Damar içi madde kullanımı, triküspit üfürüm ve septik pulmoner emboli bulguları olan bu hastada en olası etken hangisidir?	Staphylococcus aureus
v165-new-029-gogus-ag risi-ve-hipotansiyon	Göğüs ağrısı ve hipotansiyon	Sağ ventrikül infarktında preload bağımlılığı nedeniyle nitratlardan kaçınılması gerektiğini açıklama.	İnferior ST elevasyonu, hipotansiyon, juguler venöz dolgunluk ve akciğerde ral olmaması bulunan bu hastada başlangıç yönetiminde kaçınılması gereken ilaç hangisidir?	Nitrogliserin
v165-new-030-hipotansi yon-ve-elektrolit-bozukl ugu	Hipotansiyon ve elektrolit bozukluğu	Adrenal krizde hidrokortizon ve izotonik sıvı tedavisinin laboratuvar sonucu beklenmeden başlanması gerektiğini açıklama.	Hipotansiyon, hiperpigmentasyon, hiponatremi ve hiperkalemi bulunan bu hastada en uygun acil tedavi hangisidir?	İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı
v166-new-033-hiperglis emik-acil-tablo	Hiperglisemik acil tablo	DKA olgusunda sıvı resüsitasyonu, potasyum güvenliği ve insülin zamanlaması arasındaki öncelik sırasını açıklama.	Hiperglisemi, ketonemi, anyon açıklıklı metabolik asidoz ve dehidratasyon bulguları olan bu hastada ilk tedavi basamağı hangisidir?	İzotonik salin ile intravenöz sıvı resüsitasyonu başlamak
v166-new-036-ates-ve-y eni-ufurum	Ateş ve yeni üfürüm	Endokardit etkenlerini klinik bağlam ve kapak/risk faktörü ilişkisiyle ayırt etme.	Damar içi madde kullanımı, triküspit üfürüm ve septik pulmoner emboli bulguları olan bu hastada en olası etken hangisidir?	Staphylococcus aureus
v166-new-039-trombosi topeni-ve-norolojik-bulg u	Trombositopeni ve nörolojik bulgu	TTP ile ITP, DIC, HÜS ve sepsis ilişkili trombositopeniyi ayırarak tedaviyi geciktirmeme gerektiğini açıklama.	Peteşi-ekimoz, ağır trombositopeni, şistositli hemoliz ve nörolojik dalgalanma bulunan bu hastada acilen başlanması gereken tedavi hangisidir?	Acil terapötik plazma değişimi
v166-new-040-kronik-ha lsizlik-ve-hipotansiyon	Kronik halsizlik ve hipotansiyon	Primer adrenal yetmezlikte ACTH artışı ve mineralokortikoid eksikliğinin klinik-laboratuvar sonuçlarını açıklama.	Kronik halsizlik, ortostatik hipotansiyon, hiperpigmentasyon, hiponatremi ve hiperkalemi bulunan bu hastada en olası tanı hangisidir?	Primer adrenal yetmezlik
v167-new-042-asidoz-v e-hiperglisemi-tablosu	Asidoz ve hiperglisemi tablosu	DKA tedavisinde potasyum düzeyinin insülin kararını nasıl değiştirdiğini açıklama.	DKA ile uyumlu asidoz ve hiperglisemi saptanan bu hastada insülin tedavisine geçmeden önce en uygun yaklaşım hangisidir?	Potasyum replasmanı yapıp insülini potasyum güvenli aralığa çıkana kadar ertelemek
v167-new-044-uzamis-a tes-ve-ufurum	Uzamis ateş ve üfürüm	Endokardit etkenlerini klinik bağlam ve kapak/risk faktörü ilişkisiyle ayırt etme.	Diş girişimi sonrası subakut ateş, mitral kapak hastalığı ve vejetasyon bulguları olan bu hastada en olası etken hangisidir?	Streptococcus viridans
v167-new-048-hemoliz-ve-norolojik-bulgular	Hemoliz ve nörolojik bulgular	TTP tanısını şistosit, hemoliz paneli, koagülasyon paneli ve organ bulgularına dayanarak ayırma.	Ağır trombositopeni, şistositli hemoliz ve nörolojik bulgularla başvuran bu hastada en olası tanı hangisidir?	Trombotik trom bositopenik purpura

Vaka ID	Başlık	Öğrenme hedefi	Yeni soru kökü	Doğru cevap
v167-new-049-kolik-yan-agrisi	Kolik yan ağrısı	Kalsiyum oksalat, ürik asit, strüvit ve sistin taşlarını kristal/ıdrar pH/klinik bağlamla karşılaştırma.	İdrar mikroskopisinde zarf şeklinde kristaller saptanan renal kolik hastasında en olası taş tipi hangisidir?	Kalsiyum oksalat taşı
v167-new-050-akut-gogus-agrisi-ve-hipotansiyon	Akut göğüs ağrısı ve hipotansiyon	Sağ ventrikül infarktında preload bağımlılığı nedeniyle nitratlardan kaçınılması gerektiğini açıklama.	İnferior ST elevasyonu, hipotansiyon, juguler venöz dolgunluk ve akciğerde ral olmaması bulunan bu hastada nitrat verilmesinden kaçınılmasının temel nedeni hangisidir?	Sağ ventrikül preloadunu azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırması
v168-new-058-hiperglisemi-ve-asidotik-solunum	Hiperglisemi ve asidotik solunum	DKA olgusunda sıvı resüsitasyonu, potasyum güvenliği ve insülin zamanlaması arasındaki öncelik sırasını açıklama.	Hiperglisemi, ketonemi, anyon açıklıklı metabolik asidoz ve dehidratasyon bulguları olan bu hastada ilk tedavi basamağı hangisidir?	İzotonik salin ile intravenöz sıvı resüsitasyonu başlamak
v169-new-063-trombositopeni-ve-norolojik-bulgu	Trombositopeni ve nörolojik bulgu	TTP ile ITP, DIC, HÜS ve sepsis ilişkili trombositopeniyi ayırarak tedaviyi geciktirmeme mantığını açıklama.	Ağır trombositopeni, şistositli hemoliz ve geçici nörolojik bulgularla başvuran bu hastada hayat kurtarıcı ilk tedavi yaklaşımı hangisidir?	Acil terapötik plazma değişimi
v192-new-301-halsizlik-ve-direncli-hipotansiyon	Halsizlik ve dirençli hipotansiyon	Adrenal krizde hidrokortizon ve izotonik sıvı tedavisinin laboratuvar sonucu beklenmeden başlanması gerektiğini açıklama.	Hipotansiyon, hiperpigmentasyon, hiponatremi ve hiperkalemi bulunan bu hastada en uygun acil tedavi hangisidir?	İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı
v192-new-302-yasli-hastada-bilinc-bulanikligi-ve-hiperglisemi	Yaşlı hastada bilinc bulanıklığı ve hiperglisemi	HHS ve DKA ayırımında keton/asidoz/osmolalite farkını ve tedavi önceliğini açıklama.	Ağır hiperglisemi, belirgin hiperosmolalite, minimal ketoz ve dehidratasyon bulunan bu hastada ilk tedavi basamağı hangisidir?	İzotonik sıvı resüsitasyonu başlamak
v192-new-303-kabizlik-poliuri-ve-konfuzyon	Kabızlık, poliüri ve konfüzyon	Semptomatik hiperkalsemiye izotonik sıvı ve bisfosfonat tedavisinin yerini açıklama.	Semptomatik ağır hiperkalsemi, dehidratasyon ve malignite kuşkusunu bulunan bu hastada en uygun başlangıç tedavisi hangisidir?	İzotonik sıvı resüsitasyonu ve ardından intravenöz bisfosfonat tedavisi
v192-new-304-halsizlik-ve-pika	Halsizlik ve pika	Demir eksikliği anemisinde ferritin, TDBK, transferrin saturasyonu ve MCV paternini açıklama.	Yoğun adet kanaması, pika, mikrositik hipokrom anemi ve düşük ferritin bulunan bu hastada en olası tanı hangisidir?	Demir eksikliği anemisi
v192-new-305-hemoptizi-ve-bobrek-yetmezligi	Hemoptizi ve böbrek yetmezliği	Anti-GBM hastalığını ANCA vaskülit, IgA nefropatisi ve poststreptokokal GN'den ayırma.	Hemoptizi, hipoksemi, hızlı kreatinin artışı ve aktif idrar sedimenti bulunan bu hastada en olası tanı hangisidir?	Anti-GBM hastalığı

Tetkik ve Kısa Yorum Katmanı

v163-new-002-acil-elektrolit-bozuklugu - Acil elektrolit bozukluğu

Eski tetkik sayısı: 3 | Yeni tetkik sayısı: 3

Yeni tetkik başlıkları: Elektrolit ve böbrek fonksiyon paneli, Elektrokardiyografi, İdrar ve ilaç ilişkili risk değerlendirmesi

v164-new-011-acilik-ve-kusma-sonrasi-metabolik-bozulma - Açlık ve kusma sonrası metabolik bozulma

Eski tetkik sayısı: 5 | Yeni tetkik sayısı: 4

Yeni tetkik başlıkları: Arter kan gazı ve anyon açıklığı, Glukoz ve keton değerlendirmesi, Elektrolit ve böbrek fonksiyon paneli, Tetikleyici enfeksiyon taraması

Temizlenen sorunlar: Arter kan gazı -> karar tek parametreyle

v164-new-014-purpura-ve-norolojik-bulgular - Purpura ve nörolojik bulgular

Eski tetkik sayısı: 6 | Yeni tetkik sayısı: 7

Yeni tetkik başlıkları: Hemogram, Hemoliz paneli, Periferik yayma, Böbrek fonksiyonu, Koagülasyon paneli, Coombs ve ADAMTS13 değerlendirmesi, Gebelik testi

Temizlenen sorunlar: Gebelik testi / serum beta-hCG -> ektopik gebelik; Laktat dehidrogenaz -> Laktat yüksekliği doku hipoperfüzyonu; Trombosit sayısı -> BOS'ta

v164-new-017-yeni-baslayan-temporal-bas-agrisi - Yeni başlayan temporal baş ağrısı

Eski tetkik sayısı: 2 | Yeni tetkik sayısı: 3

Yeni tetkik başlıkları: İnflamasyon belirteçleri, Temporal arter ultrasonografisi, Temporal arter biyopsisi planı

v164-new-018-hemoptizi-ve-hematuri-birlikteligi - Hemoptizi ve hematüri birlikteliği

Eski tetkik sayısı: 6 | Yeni tetkik sayısı: 5

Yeni tetkik başlıkları: Böbrek fonksiyon paneli, İdrar analizi ve sediment, Akciğer görüntüleme ve oksijenasyon, Otoimmün seroloji, Böbrek biyopsisi immünfloresan inceleme

Temizlenen sorunlar: Serum kreatinin -> nefrotik tabloyu oluşturur; Akciğer grafisi -> pnömoni tanısını güçlendirir

v164-new-020-antibiyotik-sonrasi-ishal - Antibiyotik sonrası ishal

Eski tetkik sayısı: 5 | Yeni tetkik sayısı: 3

Yeni tetkik başlıkları: Hemogram ve inflamasyon paneli, Dışkıda C. difficile toksin testi, Abdominal değerlendirme

Temizlenen sorunlar: Abdominal ultrasonografi -> pnömoni tanısını güçlendirir

v165-new-021-acilik-ve-kusma-sonrasi-metabolik-bozulma - Açlık ve kusma sonrası metabolik bozulma

Eski tetkik sayısı: 5 | Yeni tetkik sayısı: 4

Yeni tetkik başlıkları: Arter kan gazı ve anyon açıklığı, Glukoz ve keton paneli, Potasyum ve böbrek fonksiyon paneli, Elektrokardiyografi

Temizlenen sorunlar: Arter kan gazı -> karar tek parametreyle

v165-new-024-ates-ve-yeni-ufurum - Ateş ve yeni üfürüm

Eski tetkik sayısı: 5 | Yeni tetkik sayısı: 4

Yeni tetkik başlıkları: Hemogram ve inflamasyon paneli, Kan kültürü, Transtorasik ekokardiyografi, Toraks BT

Temizlenen sorunlar: Transtorasik ekokardiyografi -> pnömoni tanısını güçlendirir

v165-new-029-gogus-agrisi-ve-hipotansiyon - Göğüs ağrısı ve hipotansiyon

Eski tetkik sayısı: 3 | Yeni tetkik sayısı: 3

Yeni tetkik başlıkları: Elektrokardiyografi, Kardiyak biyobelirteçler, Yatak başı ekokardiyografi

Temizlenen sorunlar: Hemogram ve temel inflamasyon paneli -> BOS'ta

v165-new-030-hipotansiyon-ve-elektrolit-bozuklugu - Hipotansiyon ve elektrolit bozukluğu

Eski tetkik sayısı: 5 | Yeni tetkik sayısı: 3

Yeni tetkik başlıkları: Elektrolit paneli, Kortizol ve ACTH değerlendirmesi, Böbrek ve hacim durumu

Temizlenen sorunlar: Gebelik testi / serum beta-hCG -> ektopik gebelik

v166-new-033-hiperglisemik-acil-tablo - Hiperglisemik acil tablo

Eski tetkik sayısı: 5 | Yeni tetkik sayısı: 4

Yeni tetkik başlıkları: Arter kan gazı ve anyon açıklığı, Glukoz ve keton değerlendirmesi, Elektrolit ve böbrek fonksiyon paneli, Tetikleyici enfeksiyon taraması

v166-new-036-ates-ve-yeni-ufurum - Ateş ve yeni üfürüm

Eski tetkik sayısı: 5 | Yeni tetkik sayısı: 3

Yeni tetkik başlıkları: Hemogram ve inflamasyon paneli, Kan kültürü, Transtorasik ekokardiyografi, Toraks BT

Temizlenen sorunlar: Transtorasik ekokardiyografi -> pnömoni tanısını güçlendirir

v166-new-039-trombositopeni-ve-norolojik-bulgu - Trombositopeni ve nörolojik bulgu

Eski tetkik sayısı: 5 | Yeni tetkik sayısı: 7

Yeni tetkik başlıkları: Hemogram, Hemoliz paneli, Periferik yayma, Böbrek fonksiyonu, Koagülasyon paneli, Coombs ve ADAMTS13 değerlendirmesi, Gebelik testi

Temizlenen sorunlar: Gebelik testi / serum beta-hCG -> ektopik gebelik; Tam kan sayımı -> BOS'ta

v166-new-040-kronik-halsizlik-ve-hipotansiyon - Kronik halsizlik ve hipotansiyon

Eski tetkik sayısı: 6 | Yeni tetkik sayısı: 3

Yeni tetkik başlıkları: Sabah kortizolü ve ACTH, Elektrolit paneli, Renin-aldosteron değerlendirmesi

Temizlenen sorunlar: Gebelik testi / serum beta-hCG -> ektopik gebelik; Plazma ACTH -> karar tek parametreyle; Sabah kortizolü -> karar tek parametreyle

v167-new-042-asidoz-ve-hiperglisemi-tablosu - Asidoz ve hiperglisemi tablosu

Eski tetkik sayısı: 6 | Yeni tetkik sayısı: 4

Yeni tetkik başlıkları: Arter kan gazı ve anyon açıklığı, Glukoz ve keton paneli, Potasyum ve böbrek fonksiyon paneli, Elektrokardiyografi

v167-new-044-uzamis-ates-ve-ufurum - Uzamış ateş ve üfürüm

Eski tetkik sayısı: 2 | Yeni tetkik sayısı: 4

Yeni tetkik başlıkları: Hemogram ve inflamasyon paneli, Kan kültürü, Transtorasik ekokardiyografi, Periferik embolik bulgular

v167-new-048-hemoliz-ve-norolojik-bulgular - Hemoliz ve nörolojik bulgular

Eski tetkik sayısı: 5 | Yeni tetkik sayısı: 7

Yeni tetkik başlıkları: Hemogram, Hemoliz paneli, Periferik yayma, Böbrek fonksiyonu, Koagülasyon paneli, Coombs ve ADAMTS13 değerlendirmesi, Gebelik testi

Temizlenen sorunlar: Trombosit sayısı -> BOS'ta

v167-new-049-kolik-yan-agrisi - Kolik yan ağrısı

Eski tetkik sayısı: 3 | Yeni tetkik sayısı: 3

Yeni tetkik başlıkları: Tam idrar analizi, Kontrastsız üriner sistem BT, İdrar mikroskopisi - kristal morfolojisi

Temizlenen sorunlar: Tam idrar tahlili -> karar tek parametreyle

v167-new-050-akut-gogus-agrisi-ve-hipotansiyon - Akut göğüs ağrısı ve hipotansiyon

Eski tetkik sayısı: 3 | Yeni tetkik sayısı: 3

Yeni tetkik başlıkları: Elektrokardiyografi, Kardiyak biyobelirteçler, Yatak başı ekokardiyografi

Temizlenen sorunlar: Akciğer grafisi -> pnömoni tanısını güçlendirir

v168-new-058-hiperglisemi-ve-asidotik-solunum - Hiperglisemi ve asidotik solunum

Eski tetkik sayısı: 5 | Yeni tetkik sayısı: 4

Yeni tetkik başlıkları: Arter kan gazı ve anyon açıklığı, Glukoz ve keton değerlendirmesi, Elektrolit ve böbrek fonksiyon paneli, Tetikleyici enfeksiyon taraması

v169-new-063-trombositopeni-ve-norolojik-bulgu - Trombositopeni ve nörolojik bulgu

Eski tetkik sayısı: 6 | Yeni tetkik sayısı: 7

Yeni tetkik başlıkları: Hemogram, Hemoliz paneli, Periferik yayma, Böbrek fonksiyonu, Koagülasyon paneli, Coombs ve ADAMTS13 değerlendirmesi, Gebelik testi

Temizlenen sorunlar: Gebelik testi / serum beta-hCG -> ektopik gebelik; Trombosit sayısı -> BOS'ta

v192-new-301-halsizlik-ve-direncli-hipotansiyon - Halsizlik ve dirençli hipotansiyon

Eski tetkik sayısı: 3 | Yeni tetkik sayısı: 3

Yeni tetkik başlıkları: Elektrolit paneli, Kortizol ve ACTH değerlendirmesi, Böbrek ve hacim durumu

Temizlenen sorunlar: Serum kortizol -> karar tek parametreyle

v192-new-302-yasli-hastada-bilinc-bulanikligi-ve-hiperglisemi - Yaşlı hastada bilinç bulanıklığı ve hiperglisemi

Eski tetkik sayısı: 5 | Yeni tetkik sayısı: 4

Yeni tetkik başlıkları: Glukoz ve osmolalite paneli, Keton ve asit-baz değerlendirmesi, Böbrek fonksiyonu ve hacim kaybı, Enfeksiyon tetikleyicisi

Temizlenen sorunlar: Abdominal ultrasonografi -> pnömoni tanısını güçlendirir

v192-new-303-kabizlik-poliuri-ve-konfuzyon - Kabızlık, poliüri ve konfüzyon

Eski tetkik sayısı: 3 | Yeni tetkik sayısı: 3

Yeni tetkik başlıkları: Kalsiyum-fosfor-PTH paneli, Böbrek ve hacim durumu, Malignite yönünden görüntüleme

Temizlenen sorunlar: PTH -> karar tek parametreyle; Akciğer grafisi -> pnömoni tanısını güçlendirir

v192-new-304-halsizlik-ve-pika - Halsizlik ve pika

Eski tetkik sayısı: 5 | Yeni tetkik sayısı: 4

Yeni tetkik başlıkları: Hemogram ve eritrosit indeksleri, Demir çalışmaları, Periferik yayma ve retikülosit, Gebelik testi

Temizlenen sorunlar: Gebelik testi / serum beta-hCG -> ektopik gebelik

v192-new-305-hemoptizi-ve-bobrek-yetmezligi - Hemoptizi ve böbrek yetmezliği

Eski tetkik sayısı: 5 | Yeni tetkik sayısı: 5

Yeni tetkik başlıkları: Böbrek fonksiyon paneli, İdrar analizi ve sediment, Akciğer görüntüleme ve oksijenasyon, Otoimmün seroloji, Böbrek biyopsisi immünfloresan inceleme

Temizlenen sorunlar: Serum kreatinin -> nefrotik tabloyu oluşturur; Akciğer grafisi -> pnömoni tanısını güçlendirir

Seenek ve Feedback Yeniden Yazımı

v163-new-002-acil-elektrolit-bozuklugu - Acil elektrolit bozukluęu

Yeni seenekler: İntervenöz kalsiyum glukonat verilmesi | İntervenöz insülin ve glukoz verilmesi | Nebülide salbutamol verilmesi | Sodyum zirkonyum/potasyum bağlayıcı tedavi planlanması | Acil hemodiyaliz hazırlığı yapılması

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Deęiştirilen seenek metni: 2

v164-new-011-aclik-ve-kusma-sonrasi-metabolik-bozulma - Açlık ve kusma sonrası metabolik bozulma

Yeni seenekler: İzotonik salin ile intravenöz sıvı resüsitasyonu başlamak | İntervenöz düzenli insülin infüzyonunu sıvı ve potasyum deęerlendirmesinden önce başlamak | Sodyum bikarbonat infüzyonunu ilk tedavi olarak vermek | Subkutan hızlı etkili insülinle ayaktan izlem planlamak | Potasyum düzeyi düşük olmadan yüksek doz potasyum replasmanı yapmak

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Deęiştirilen seenek metni: 5

v164-new-014-purpura-ve-norolojik-bulgular - Purpura ve nörolojik bulgular

Yeni seenekler: Acil terapötik plazma deęiřimi | Rutin trombosit transfüzyonu | Yüksek doz intravenöz immünglobulin | Düşük molekül aęırlıklı heparin | Eculizumab tedavisi

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Deęiştirilen seenek metni: 3

v164-new-017-yeni-baslayan-temporal-bas-agrisi - Yeni başlayan temporal baş ağrısı

Yeni seenekler: Yüksek doz sistemik kortikosteroid başlamak | Temporal arter biyopsisi sonucunu beklemek | Triptan tedavisi başlamak | Nonsteroid antiinflatuvar tedaviyle izlemek | Oral antibiyotik tedavisi başlamak

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Deęiştirilen seenek metni: 2

v164-new-018-hemoptizi-ve-hematuri-birlikteligi - Hemoptizi ve hematüri birliktelięi

Yeni seenekler: Anti-GBM hastalığı | IgA nefropatisi | Poststreptokokal glomerülofrit | ANCA ilişkili vaskülit | Minimal deęişiklik hastalığı

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Deęiştirilen seenek metni: 2

v164-new-020-antibiyotik-sonrasi-ishal - Antibiyotik sonrası ishal

Yeni seenekler: Oral vankomisin tedavisi başlanması | Loperamid ile ishali baskılamak | Probiyotik verip antibiyotik tedavisi olmadan izlemek | İntervenöz aminoglikozid başlanması | Peritonit bulgusu olmadan acil kolektomi yapmak

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Deęiştirilen seenek metni: 3

v165-new-021-aclik-ve-kusma-sonrasi-metabolik-bozulma - Açlık ve kusma sonrası metabolik bozulma

Yeni seenekler: Potasyum replasmanı yapıp insülini potasyum güvenli aralıęa ıkana kadar ertelemek | Potasyum düzeltilmeden intravenöz insülin infüzyonuna başlamak | Sodyum bikarbonat infüzyonunu ilk tedavi olarak vermek | Subkutan hızlı etkili insülin uygulamak | Acil hemodiyaliz uygulamak

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Deęiştirilen seenek metni: 4

v165-new-024-ates-ve-yeni-ufurum - Ateř ve yeni üfürüm

Yeni seenekler: Staphylococcus aureus | Streptococcus viridans | Staphylococcus epidermidis | Enterococcus faecalis | Coxiella burnetii

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Deęiştirilen seenek metni: 0

v165-new-029-gogus-agrisi-ve-hipotansiyon - Göęüs ağrısı ve hipotansiyon

Yeni seenekler: Nitrogliserin | Aspirin | Heparin | Klopidoğrel | Atropin

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Deęiştirilen seenek metni: 0

v165-new-030-hipotansiyon-ve-elektrolit-bozuklugu - Hipotansiyon ve elektrolit bozukluęu

Yeni seenekler: İntervenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı | Hipertonik salin ve sıvı kısıtlaması uygulamak | Spironolakton başlamak | Oral fludrokortizonla ayaktan izlem planlamak | Sıvı vermeden loop diüretik uygulamak

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Deęiştirilen seenek metni: 4

v166-new-033-hiperglisemik-acil-tablo - Hiperglisemik acil tablo

Yeni seenekler: İzotonik salin ile intravenöz sıvı resüsitasyonu başlamak | İntervenöz düzenli insülin infüzyonunu sıvı ve potasyum deęerlendirmesinden önce başlamak | Sodyum bikarbonat infüzyonunu ilk tedavi olarak vermek | Subkutan hızlı etkili insülinle ayaktan izlem planlamak | Potasyum düzeyi düşük olmadan yüksek doz potasyum replasmanı yapmak

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Deęiştirilen seenek metni: 5

v166-new-036-ates-ve-yeni-ufurum - Ateř ve yeni üfürüm

Yeni seenekler: Staphylococcus aureus | Streptococcus viridans | Staphylococcus epidermidis | Enterococcus faecalis | Coxiella burnetii

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Deęiştirilen seenek metni: 1

v166-new-039-trombositopeni-ve-norolojik-bulgu - Trombositopeni ve nörolojik bulgu

Yeni seenekler: Acil terapötik plazma deęiřimi | Rutin trombosit transfüzyonu | Yüksek doz intravenöz immünglobulin | Düşük molekül aęırlıklı heparin | Eculizumab tedavisi

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Deęiştirilen seenek metni: 4

v166-new-040-kronik-halsizlik-ve-hipotansiyon - Kronik halsizlik ve hipotansiyon

Yeni seçenekler: Primer adrenal yetmezlik | Sekonder adrenal yetmezlik | Uygunsuz ADH salınımı sendromu | Hipertiroidi | Cushing sendromu

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Değiştirilen seçenek metni: 1

v167-new-042-asidoz-ve-hiperglisemi-tablosu - Asidoz ve hiperglisemi tablosu

Yeni seçenekler: Potasyum replasmanı yapıp insülini potasyum güvenli aralığa çıkana kadar ertelemek | Potasyum düzeltilmeden intravenöz insülin infüzyonuna başlamak | Sodyum bikarbonat infüzyonunu ilk tedavi olarak vermek | Subkutan hızlı etkili insülin uygulamak | Acil hemodiyaliz uygulamak

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Değiştirilen seçenek metni: 5

v167-new-044-uzamis-ates-ve-ufurum - Uzamış ateş ve üfürüm

Yeni seçenekler: Streptococcus viridans | Staphylococcus aureus | Enterococcus faecalis | Staphylococcus epidermidis | Candida albicans

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Değiştirilen seçenek metni: 1

v167-new-048-hemoliz-ve-norolojik-bulgular - Hemoliz ve nörolojik bulgular

Yeni seçenekler: Trombotik trombositopenik purpura | İmmün trombositopenik purpura | Dissemine intravasküler koagülasyon | Hemolitik üremik sendrom | Akut lösemi

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Değiştirilen seçenek metni: 4

v167-new-049-kolik-yan-agrisi - Kolik yan ağrısı

Yeni seçenekler: Kalsiyum oksalat taşı | Ürik asit taşı | Strüvit taşı | Sistin taşı | Ksantin taşı

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Değiştirilen seçenek metni: 0

v167-new-050-akut-gogus-agrisi-ve-hipotansiyon - Akut göğüs ağrısı ve hipotansiyon

Yeni seçenekler: Sağ ventrikül preloadunu azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırması | Koroner vazospazmı artırması | Trombosit agregasyonunu artırması | Atriyoventriküler iletimi tamamen bloke etmesi | Miyokard oksijen tüketimini doğrudan artırması

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Değiştirilen seçenek metni: 0

v168-new-058-hiperglisemi-ve-asidotik-solunum - Hiperglisemi ve asidotik solunum

Yeni seçenekler: İzotonik salin ile intravenöz sıvı resüsitasyonu başlamak | İntravenöz düzenli insülin infüzyonunu sıvı ve potasyum değerlendirmesinden önce başlamak | Sodyum bikarbonat infüzyonunu ilk tedavi olarak vermek | Subkutan hızlı etkili insülinle ayakta izlem planlamak | Potasyum düzeyi düşük olmadan yüksek doz potasyum replasmanı yapmak

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Değiştirilen seçenek metni: 5

v169-new-063-trombositopeni-ve-norolojik-bulgu - Trombositopeni ve nörolojik bulgu

Yeni seçenekler: Acil terapötik plazma değişimi | Rutin trombosit transfüzyonu | Yüksek doz intravenöz immünglobulin | Düşük molekül ağırlıklı heparin | Eculizumab tedavisi

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Değiştirilen seçenek metni: 5

v192-new-301-halsizlik-ve-direncli-hipotansiyon - Halsizlik ve dirençli hipotansiyon

Yeni seçenekler: İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı | Hipertonik salin ve sıvı kısıtlaması uygulamak | Spironolakton başlamak | Oral fludrokortizonla ayakta izlem planlamak | Sıvı vermeden loop diüretik uygulamak

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Değiştirilen seçenek metni: 5

v192-new-302-yasli-hastada-bilinc-bulanikligi-ve-hiperglisemi - Yaşlı hastada bilinç bulanıklığı ve hiperglisemi

Yeni seçenekler: İzotonik sıvı resüsitasyonu başlamak | Subkutan kısa etkili insülinle hiperglisemiyi düzelterip sıvıyı ertelemek | Oral glukoz yüklemesi yapmak | Sıvı vermeden yoğun diüretik başlamak | Metformin dozunu artırmak

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Değiştirilen seçenek metni: 1

v192-new-303-kabizlik-poliuri-ve-konfuzyon - Kabızlık, poliüri ve konfüzyon

Yeni seçenekler: İzotonik sıvı resüsitasyonu ve ardından intravenöz bisfosfonat tedavisi | Kalsiyum replasmanı ve D vitamini yüklemesi | Tiazid diüretik başlamak | Oral hidrasyonla izleyip bisfosfonatı ertelemek | Metformin başlamak

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Değiştirilen seçenek metni: 1

v192-new-304-halsizlik-ve-pika - Halsizlik ve pika

Yeni seçenekler: Demir eksikliği anemisi | Vitamin B12 eksikliği anemisi | Aplastik anemi | Akut hemolitik anemi | Polisitemia vera

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Değiştirilen seçenek metni: 0

v192-new-305-hemoptizi-ve-bobrek-yetmezligi - Hemoptizi ve böbrek yetmezliği

Yeni seçenekler: Anti-GBM hastalığı | IgA nefropatisi | Poststreptokokal glomerülofrit | ANCA ilişkili vaskülit | Minimal değişiklik hastalığı

Sıfırdan yazılan feedback sayısı: 5 | Değiştirilen seçenek metni: 2

Klinik Karar ve Acil Tedavi Önceliği

v163-new-002-acil-elektrolit-bozuklugu - Acil elektrolit bozukluğu

Doğru cevap: İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi

Sınav notu: Hiperkalemi + EKG değişikliği = ilk basamak IV kalsiyum; insülin-glukoz ve beta-agonist potasyumu düşürür ama kalsiyumun yerini tutmaz.

Kanıt zinciri: Kronik böbrek hastalığı ve ACE inhibitörü kullanımı potasyum atılımını azaltarak hiperkalemi riskini artırır. / Potasyumun 7.1 mmol/L olması ve EKG’de sivri T dalgaları/QRS genişleme eğilimi aritmi tehdidini gösterir. / EKG değişikliği olan hiperkalemiye potasyumu düşürmeden önce miyokard membranı intravenöz kalsiyumla stabilize edilir.

v164-new-011-acilik-ve-kusma-sonrasi-metabolik-bozulma - Açlık ve kusma sonrası metabolik bozulma

Doğru cevap: İzotonik salin ile intravenöz sıvı resüsitasyonu başlamak

Sınav notu: DKA’da ilk yaklaşım sıvı resüsitasyonudur; insülin başlanmadan önce potasyum mutlaka kontrol edilir, potasyum düşükse önce potasyum replasmanı yapılır.

Kanıt zinciri: Kusma, poliüri, kuru mukoza, hipotansiyon ve taşikardi belirgin hacim kaybını gösterir. / Hiperglisemi, keton pozitifliği ve yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz DKA paternini oluşturur. / Potasyum düzeyi insülin başlanmadan önce değerlendirilmelidir; ilk acil basamak dolaşımı izotonik sıvıyla düzeltmektir.

v164-new-014-purpura-ve-norolojik-bulgular - Purpura ve nörolojik bulgular

Doğru cevap: Acil terapötik plazma değişimi

Sınav notu: TTP’de şistositli MAHA + ağır trombositopeni + nörolojik bulgu varsa pentadın tamamı ve ADAMTS13 sonucu beklenmeden plazma değişimi başlanır.

Kanıt zinciri: Peteşi, ekimoz ve çok düşük trombosit sayısı ağır trombositopeniye bağlı kanama eğilimini gösterir. / Şistositler, yüksek LDH, düşük haptoglobin ve indirekt bilirubin artışı mikroanjiyopatik hemolitik anemi paternini destekler. / Dalgalanan bilinç bulanıklığı ve kreatinin yüksekliği trombotik mikroanjiyopatinin organ etkilenimi oluşturduğunu gösterir.

v164-new-017-yeni-baslayan-temporal-bas-agrisi - Yeni başlayan temporal baş ağrısı

Doğru cevap: Yüksek doz sistemik kortikosteroid başlamak

Sınav notu: Dev hücreli arteritte görme semptomu varsa biyopsi beklenmez; yüksek doz kortikosteroid hemen başlanır.

Kanıt zinciri: Yetmiş yaş üzerinde yeni başlangıçlı temporal baş ağrısı ve temporal arter hassasiyeti dev hücreli arterit için kırmızı bayraktır. / Çene klodikasyonu ve geçici görme bulanıklığı kraniyal arter iskemisini düşündürür. / ESR/CRP yüksekliği inflamatuvar vaskülit olasılığını destekler ve kalıcı görme kaybını önlemek için steroid acildir.

v164-new-018-hemoptizi-ve-hematuri-birlikteligi - Hemoptizi ve hematüri birlikteliği

Doğru cevap: Anti-GBM hastalığı

Sınav notu: Anti-GBM hastalığı = akciğer hemorajisi + hızlı ilerleyen glomerülonefrit + anti-GBM/lineer IgG paterni.

Kanıt zinciri: Hemoptizi, hipoksemi ve bilateral alveoler opasiteler alveoler hemoraji düşündürür. / Dismorfik eritrosit, eritrosit silendiri ve hızlı kreatinin artışı hızlı ilerleyen glomerülonefrit paternini gösterir. / Anti-GBM antikoru ve lineer IgG birikimi akciğer-böbrek sendromunda anti-GBM hastalığını destekler.

v164-new-020-antibiyotik-sonrasi-ishal - Antibiyotik sonrası ishal

Doğru cevap: Oral vankomisin tedavisi başlanması

Sınav notu: Antibiyotik sonrası sulu ishal + toksin pozitifliği C. difficile kolitidir; antitoksin tek başına verilmez, fulminan bulgu yoksa oral tedavi başlanır.

Kanıt zinciri: Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı ve hastane yatışı C. difficile için güçlü risk oluşturur. / Sulu ishal, ateş, lökositoz ve toksin A/B pozitifliği semptomatik C. difficile kolitini destekler. / Peritonit veya toksik megakolon bulgusu olmadığından ilk yaklaşım lümen içinde etkili oral tedavidir.

v165-new-021-acilik-ve-kusma-sonrasi-metabolik-bozulma - Açlık ve kusma sonrası metabolik bozulma

Doğru cevap: Potasyum replasmanı yapıp insülini potasyum güvenli aralığa çıkana kadar ertelemek

Sınav notu: DKA’da K+ <3.3 mmol/L ise önce potasyum verilir; insülin potasyum güvenli aralığa çıkana kadar ertelenir.

Kanıt zinciri: Hiperglisemi, keton pozitifliği ve yüksek anyon açıklıklı asidoz DKA paternini oluşturur. / Serum potasyumunun 2.9 mmol/L olması, toplam potasyum kaybının tedavi güvenliği açısından kritik olduğunu gösterir. / İnsülin potasyumu hücre içine kaydıracağından hipokalemi düzeltilmeden başlanması aritmi riskini artırır.

v165-new-024-ates-ve-yeni-ufurum - Ateş ve yeni üfürüm

Doğru cevap: Staphylococcus aureus

Sınav notu: IVDU + triküspit endokarditi + septik pulmoner emboli denince S. aureus önceliklidir.

Kanıt zinciri: Damar içi madde kullanımı sağ taraf endokarditi için güçlü risk faktörüdür. / Triküspit odakta yeni üfürüm ve ekokardiyografide vejetasyon enfektif endokarditi destekler. / Septik pulmoner emboli ve akut toksik tablo Staphylococcus aureus olasılığını artırır.

v165-new-029-gogus-agrisi-ve-hipotansiyon - Göğüs ağrısı ve hipotansiyon

Doğru cevap: Nitroglicerini

Sınav notu: İnferior MI + hipotansiyon + JVD + temiz akciğer = sağ ventrikül MI düşün; nitrat verme, preloadu koru.

Kanıt zinciri: İnförör ST elevasyonu akut koroner oklüzyonu düşündürür. / Hipotansiyon, bradikardi, juguler venöz dolgunluk ve akciğerde ral olmaması sağ ventrikül tutulumunu destekler. / Sağ ventrikül infarktında nitrat preloadu azaltarak kardiyak outputu ve kan basıncını düşürebilir.

v165-new-030-hipotansiyon-ve-elektrolit-bozuklugu - Hipotansiyon ve elektrolit bozukluğu

Doğru cevap: İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı

Sınav notu: Adrenal kriz şüphesinde kortizol/ACTH sonucu beklenmez; hidrokortizon ve izotonik sıvı birlikte başlanır.

Kanıt zinciri: Kilo kaybı, hiperpigmentasyon ve tuz isteği kronik primer adrenal yetmezlik zeminini düşündürür. / Hipotansiyon, hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi adrenal kriz paternini oluşturur. / Enfeksiyon veya kusma gibi stres durumları adrenal rezervi yetersiz hastada akut krizi tetikleyebilir.

v166-new-033-hiperglisemik-acil-tablo - Hiperglisemik acil tablo

Doğru cevap: İzotonik salin ile intravenöz sıvı resüsitasyonu başlamak

Sınav notu: DKA'da ilk yaklaşım sıvı resüsitasyonudur; insülin başlanmadan önce potasyum mutlaka kontrol edilir, potasyum düşükse önce potasyum replasmanı yapılır.

Kanıt zinciri: Kusma, poliüri, kuru mukoza, hipotansiyon ve taşikardi belirgin hacim kaybını gösterir. / Hiperglisemi, keton pozitifliği ve yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz DKA paternini oluşturur. / Potasyum düzeyi insülin başlanmadan önce değerlendirilmelidir; ilk acil basamak dolaşımı izotonik sıvıyla düzeltmektir.

v166-new-036-ates-ve-yeni-ufurum - Ateş ve yeni üfürüm

Doğru cevap: Staphylococcus aureus

Sınav notu: IVDU + triküspit endokarditi + septik pulmoner emboli denince S. aureus önceliklidir.

Kanıt zinciri: Damar içi madde kullanımı sağ taraf endokarditi için güçlü risk faktörüdür. / Triküspit odakta yeni üfürüm ve ekokardiyografide vejetasyon enfektif endokarditi destekler. / Septik pulmoner emboli ve akut toksik tablo Staphylococcus aureus olasılığını artırır.

v166-new-039-trombositopeni-ve-norolojik-bulgu - Trombositopeni ve nörolojik bulgu

Doğru cevap: Acil terapötik plazma değişimi

Sınav notu: TTP'de şistositli MAHA + ağır trombositopeni + nörolojik bulgu varsa pentadın tamamı ve ADAMTS13 sonucu beklenmeden plazma değişimi başlanır.

Kanıt zinciri: Peteşi, ekimoz ve çok düşük trombosit sayısı ağır trombositopeniye bağlı kanama eğilimini gösterir. / Şistositler, yüksek LDH, düşük haptoglobin ve indirekt bilirubin artışı mikroanjiyopatik hemolitik anemi paternini destekler. / Dalgalanan bilinç bulanıklığı ve kreatinin yüksekliği trombotik mikroanjiyopatinin organ etkilenimi oluşturduğunu gösterir.

v166-new-040-kronik-halsizlik-ve-hipotansiyon - Kronik halsizlik ve hipotansiyon

Doğru cevap: Primer adrenal yetmezlik

Sınav notu: Primer adrenal yetmezlikte ACTH yüksekliği hiperpigmentasyon yapar; aldosteron eksikliği hiperkalemiye yol açar.

Kanıt zinciri: Ortostatik yakınmalar, kilo kaybı, tuz isteği ve hiperpigmentasyon kronik primer adrenal yetmezliği düşündürür. / Düşük kortizol ile yüksek ACTH birlikteliği adrenal korteks düzeyinde yetmezliği gösterir. / Hiponatremi ve hiperkalemi mineralokortikoid eksikliğini destekleyerek sekonder adrenal yetmezliği geri plana iter.

v167-new-042-asidoz-ve-hiperglisemi-tablosu - Asidoz ve hiperglisemi tablosu

Doğru cevap: Potasyum replasmanı yapıp insülini potasyum güvenli aralığa çıkana kadar ertelemek

Sınav notu: DKA'da K+ <3.3 mmol/L ise önce potasyum verilir; insülin potasyum güvenli aralığa çıkana kadar ertelenir.

Kanıt zinciri: Hiperglisemi, keton pozitifliği ve yüksek anyon açıklıklı asidoz DKA paternini oluşturur. / Serum potasyumunun 3.0 mmol/L olması, toplam potasyum kaybının tedavi güvenliği açısından kritik olduğunu gösterir. / İnsülin potasyumu hücre içine kaydıracağından hipokalemi düzeltilmeden başlanması aritmi riskini artırır.

v167-new-044-uzamis-ates-ve-ufurum - Uzamış ateş ve üfürüm

Doğru cevap: Streptococcus viridans

Sınav notu: Diş işlemi + subakut doğal kapak endokarditi denince viridans streptokoklar akla gelir.

Kanıt zinciri: Diş çekimi sonrası subakut ateş ve gece terlemesi doğal kapak endokarditini düşündürür. / Mitral kapak hastalığı ve ekokardiyografide vejetasyon enfektif endokardit kanıtı sağlar. / Subakut seyir ve ağız florası ilişkisi Streptococcus viridans olasılığını öne çıkarır.

v167-new-048-hemoliz-ve-norolojik-bulgular - Hemoliz ve nörolojik bulgular

Doğru cevap: Trombotik trombositopenik purpura

Sınav notu: TTP tanısında pentadın tamamını bekleme; MAHA + trombositopeni + nörolojik bulgu yeterli klinik alarmdır.

Kanıt zinciri: Ağır trombositopeni peteşi ve mukozal kanama eğilimini açıklar. / Şistosit, LDH yüksekliği, düşük haptoglobin ve indirekt bilirubin artışı MAHA paternini oluşturur. / Nörolojik dalgalanma ve böbrek etkilenimi TTP'de mikrotrombotik organ hasarını düşündürür.

v167-new-049-kolik-yan-agrısı - Kolik yan ağrısı

Doğru cevap: Kalsiyum oksalat taşı

Sınav notu: Kalsiyum oksalat kristali zarf şeklindedir; strüvit alkali idrar/enfeksiyon, sistin heksagonal kristal, ürik asit asidik idrarla ilişkilidir.

Kanıt zinciri: Kolik tarzda kasiğe yayılan yan ağrısı ve mikroskopik hematüri renal taşı düşündürür. / Kontrastsız BT distal üreterde taş ve hafif hidroureteronefroz gösterir. / Zarf şeklindeki kristaller kalsiyum oksalat taşıyla uyumludur.

v167-new-050-akut-gogus-agrisi-ve-hipotansiyon - Akut göğüs ağrısı ve hipotansiyon

Doğru cevap: Sağ ventrikül preloadunu azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırması

Sınav notu: İnförior MI + hipotansiyon + JVD + temiz akciğer = sağ ventrikül MI düşün; nitrat verme, preloadu koru.

Kanıt zinciri: İnförior ST elevasyonu akut koroner oklüzyonu düşündürür. / Hipotansiyon, bradikardi, juguler venöz dolgunluk ve akciğerde ral olmaması sağ ventrikül tutulumunu destekler. / Sağ ventrikül infarktında nitrat preloadu azaltarak kardiyak outputu ve kan basıncını düşürebilir.

v168-new-058-hiperglisemi-ve-asidotik-solunum - Hiperglisemi ve asidotik solunum

Doğru cevap: İzotonik salin ile intravenöz sıvı resüsitasyonu başlamak

Sınav notu: DKA'da ilk yaklaşım sıvı resüsitasyonudur; insülin başlanmadan önce potasyum mutlaka kontrol edilir, potasyum düşüğe önce potasyum replasmanı yapılır.

Kanıt zinciri: Kusma, poliüri, kuru mukoza, hipotansiyon ve taşikardi belirgin hacim kaybını gösterir. / Hiperglisemi, keton pozitifliği ve yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz DKA paternini oluşturur. / Potasyum düzeyi insülin başlanmadan önce değerlendirilmelidir; ilk acil basamak dolaşımı izotonik sıvıyla düzeltmektir.

v169-new-063-trombositopeni-ve-norolojik-bulgu - Trombositopeni ve nörolojik bulgu

Doğru cevap: Acil terapötik plazma değişimi

Sınav notu: TTP'de şistositli MAHA + ağır trombositopeni + nörolojik bulgu varsa pentadin tamamı ve ADAMTS13 sonucu beklenmeden plazma değişimi başlanır.

Kanıt zinciri: Peteşi, ekimoz ve çok düşük trombosit sayısı ağır trombositopeniye bağlı kanama eğilimini gösterir. / Şistositler, yüksek LDH, düşük haptoglobin ve indirekt bilirubin artışı mikroanjiyopatik hemolitik anemi paternini destekler. / Dalgalanan bilinç bulanıklığı ve kreatinin yüksekliği trombotik mikroanjiyopatinin organ etkilenimi oluşturduğunu gösterir.

v192-new-301-halsizlik-ve-direncli-hipotansiyon - Halsizlik ve dirençli hipotansiyon

Doğru cevap: İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı

Sınav notu: Adrenal kriz şüphesinde kortizol/ACTH sonucu beklenmez; hidrokortizon ve izotonik sıvı birlikte başlanır.

Kanıt zinciri: Kilo kaybı, hiperpigmentasyon ve tuz isteği kronik primer adrenal yetmezlik zeminini düşündürür. / Hipotansiyon, hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi adrenal kriz paternini oluşturur. / Enfeksiyon veya kusma gibi stres durumları adrenal rezervi yetersiz hastada akut krizi tetikleyebilir.

v192-new-302-yasli-hastada-bilinc-bulanikligi-ve-hiperglisemi - Yaşlı hastada bilinç bulanıklığı ve hiperglisemi

Doğru cevap: İzotonik sıvı resüsitasyonu başlamak

Sınav notu: HHS'de ilk basamak sıvıdır; hiperosmolalite yavaş ve güvenli düzeltilir, insülin sıvı/potasyum değerlendirmesiyle düzenlenir.

Kanıt zinciri: Yaşlı tip 2 diyabetli hastada enfeksiyon sonrası bilinç bulanıklığı ve derin dehidratasyon gelişmiştir. / Serum glukozu ve efektif osmolalitenin çok yüksek olması HHS paternini destekler. / Minimal ketoz ve normal pH DKA'dan ayrımı sağlar; ilk tedavi hacim açığını izotonik sıvıyla düzeltmektir.

v192-new-303-kabizlik-poliuri-ve-konfuzyon - Kabızlık, poliüri ve konfüzyon

Doğru cevap: İzotonik sıvı resüsitasyonu ve ardından intravenöz bisfosfonat tedavisi

Sınav notu: Ağır semptomatik hiperkalsemiye ilk adım izotonik sıvıdır; malignite ilişkili tabloda bisfosfonat kalıcı kontrol için eklenir.

Kanıt zinciri: Konfüzyon, kabızlık, poliüri ve dehidratasyon semptomatik ağır hiperkalsemiyi gösterir. / Düzeltilmiş kalsiyumun 14.6 mg/dL olması ve PTH'nin baskılanması PTH dışı hiperkalsemi lehinedir. / Kilo kaybı, sigara öyküsü, akciğer kitlesi ve PTHrP yüksekliği malignite ilişkili hiperkalsemiyi destekler.

v192-new-304-halsizlik-ve-pika - Halsizlik ve pika

Doğru cevap: Demir eksikliği anemisi

Sınav notu: Düşük ferritin demir eksikliği için en güçlü ipucudur; B12 eksikliği makrositoz yapar, aplastik anemi pansitopeniyle gelir.

Kanıt zinciri: Yoğun adet kanaması kronik demir kaybı için güçlü öykü oluşturur. / Pika, solukluk, mikrositoz ve hipokromi demir eksikliği anemisini düşündürür. / Düşük ferritin, düşük serum demiri, yüksek TDBK ve düşük transferrin saturasyonu tanıyı laboratuvar olarak destekler.

v192-new-305-hemoptizi-ve-bobrek-yetmezligi - Hemoptizi ve böbrek yetmezliği

Doğru cevap: Anti-GBM hastalığı

Sınav notu: Anti-GBM hastalığı = akciğer hemorajisi + hızlı ilerleyen glomerülofrit + anti-GBM/lineer IgG paterni.

Kanıt zinciri: Hemoptizi, hipoksemi ve bilateral alveoler opasiteler alveoler hemoraji düşündürür. / Dismorfik eritrosit, eritrosit silindiri ve hızlı kreatinin artışı hızlı ilerleyen glomerülofrit paternini gösterir. / Anti-GBM antikor ve lineer IgG birikimi akciğer-böbrek sendromunda anti-GBM hastalığını destekler.